Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 30ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FÓRUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810296

Processo nº **0062288-78.2022.8.17.2001**

AUTORA: SILVIA FREITAS WANDERLEY

RÉ: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

Vistos, etc...

SILVIA FREITAS WANDERLEY ajuizou a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA contra UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, argumentando, em síntese:

1. Que ela, autora, atualmente com 79 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde requerido, Unimed, cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrica, carteirinha nº 034 0087000173007, cujo contrato em tela é o Coletivo Empresarial, já que é firmado através do órgão do qual a autora é aposentada, qual seja TRT 6ª Região.

2. Relata que foi diagnosticada em 2006 com neoplasia maligna, sendo submetida a gastrectomia subtotal em 23/10/2006. Em 2008 foi diagnosticada OSTEOPOROSE. Em 2010, devido a progressão das gastrites, a referida médica suspendeu o alendronato e iniciou tratamento com outro bifosfonato, mantendo esta terapia até 11/12/2020, quando foi detectado aumento da OSTEOPOROSE. Foi, então, indicado o uso de outro medicamento mais adequado, de outra classe terapêutica (anticorpo monoclonal), o DENOSUMABE – PROLIA – 60 MG/SC – 6/6 meses).

3. Registra ainda a autora, que o PROLIA está devidamente registrado na ANVISA, e se trata de uma medicação injetável de altíssimo custo, que é aplicado na paciente por profissional capacitado para tanto em clínica ou hospital. Tal medicamento é o mais indicado para pacientes como a autora, que é portadora de neoplasia maligna, já que o medicamento contém denosumabe, uma proteína (chamada de anticorpo monoclonal) que interfere na ação de outra proteína, a fim de tratar a perda óssea e a osteoporose, que ocorre pela diminuição da densidade óssea.

4. No detalhamento dos fatos, diz que ao solicitar o medicamento, houve negativa da ré. Foi solicitada reanálise, mas também ocorreu uma nova negativa.

Assim, requer a demandante que este juízo determine a obrigatoriedade da ré para fornecimento do medicamento, conforme solicitado no laudo médico anexo; declaração de invalidade da cláusula que exclui da cobertura o medicamento; condenação em indenização por danos morais no valor que acredita e espera que seja arbitrado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Decisão de ID 107703064 deferindo a tutela de urgência.

A parte ré foi citada e apresentou a contestação de ID 108688634, alegando preliminarmente ser a Justiça Federal competente para proceder o feito, uma vez que o referido negócio jurídico se trata de plano de saúde de autogestão, denominado TRT6 Saúde, oriundo do Programa de Autogestão em Saúde do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Aduz ainda que a análise da cobertura solicitada pela autora (internação de alta complexidade) é prerrogativa exclusiva do TRT6 Saúde. Afirma que a Unimed Recife sequer tem autorização para prestar serviços de Home-care aos beneficiários do TRT-6, já que a atenção domiciliar, nesses casos, é prestada pelo TRT-6.

Em consequência das alegações acima citadas, requer a denunciação da lide da União por intermédio do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, bem como a declaração de ilegitimidade passiva da Unimed Recife, porquanto é a União (TRT 6ª) que detém a prerrogativa exclusiva de autorizar ou não a cobertura solicitada requerida nesta ação, e não o plano de saúde réu, que é parte flagrantemente ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

No mérito sustenta que a avaliação de complexidade para autorização dos procedimentos é realizada diretamente pelo TRT-6, não havendo qualquer gerência por parte da Unimed Recife. Ademais, sustenta que a ré não praticou nenhuma conduta capaz de ensejar dano moral em favor da demandante, requerendo assim a total improcedência dos pedidos autorais.

A demandante apresentou a réplica de ID 111283437.

A ré peticionou sob o ID 110154685 informando não haver mais provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Decisão de ID 123720404, considerando o interesse da União no feito, e determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

Desta decisão, a autora interpôs recurso de Agravo de Instrumento, tombado sob o nº 0004980-05.2023.8.17.9000.

Através da Decisão Interlocutória de ID 128745831, o relator da 4ª Câmara Cível deu provimento ao recurso de agravo, deferindo a suspensão da Decisão de ID 123720404, determinando que os autos permanecessem nesta Corte de Justiça.

Ato contínuo, em 05/07/2023 fora juntado aos presentes o julgamento colegiado do agravo de instrumento sob o ID 137058982, mantendo-se o entendimento da Decisão de ID 128745831 que entendeu pela competência da Justiça Estadual para apreciação do feito.

É o relatório. DECIDO.

1. Das Preliminares: Da competência da Justiça Federal; Da denunciação da lide da União, por intermédio do TRT 6ª Região; Da ilegitimidade passiva da Unimed Recife:

De início passo a analisar as correlatas preliminares de competência da Justiça Federal para analisar o feito, devido ao suposto interesse da União na causa, por intermédio do TRT da 6ª Região, com a consequente denunciação da lide da União, bem como da ilegitimidade passiva da Unimed Recife.

Pois bem, verifico que em julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela autora, a 4ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça deferiu o recurso, prolatando a seguinte decisão colegiada:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PACTUADO POR EMPRESA FEDERAL CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO FEDERAL. CASO CONCRETO.MATERIA PRIVADA. JUSTIÇA COMUM. AGRAVO PROVIDO.
> 1. Controvérsia acerca da competência da Justiça Federal para julgamento de demanda entre usuário e operadora de plano de saúde. 2. Teses para os efeitos do art. 947, § 3º, do CPC/2015: **2.1. Compete à Justiça comum o julgamento das demandas entre usuário e operadora plano de saúde, e, embora pactuado por empresa federal, é operado pela UNIMED, empesa privada.** 3. Agravo de Instrumento provido. Decisão unânime.
>
> (TJPE - AGRAVO DE INSTRUMENTO 0004980-05.2023.8.17.9000, Rel. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho - 4ª Câmara Cível, julgado em 04/07/2023 - destaque nosso)

Sem mais delongas, e na medida em que a supracitada matéria já fora julgada pelo segundo grau, registro o seguinte apontamento: "*Não há discussão sobre contrato de trabalho ou direitos inerentes ao serviço entre a Estipulante – TRT Saúde e Seguradora – Unimed, assim, entendo que não há interesse da União para figurar no feito, já que a demanda circunda na relação privada entre Seguradora e Segurado , o que atrai a competência da Justiça comum.*".

Nesse ser assim, nos termos do aludido *decisum*, **rejeito as preliminares de incompetência da justiça estadual, bem como da ilegitimidade passiva da Unimed Recife**, nos exatos termos do acórdão prolatado.

Lado outro, no que se refere à denunciação da lide da União, tenho que restou bem fundamentado que a relação entre as partes deste processo é eminentemente **privada**, sujeitando-se ao regramento previsto na Lei nº 9.656/1999. Em outras palavras, o cerne da questão se refere à relação privada entre a autora e seu plano de saúde, a Unimed Recife, não havendo que se falar em denunciação da lide, porquanto o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 125 do CPC.

Outrossim,

Posto isso, **indefiro o pedido de denunciação da lide**.

2. Do Mérito.

A presente hipótese dispensa a produção de novas provas, eis que os documentos juntados aos autos permitem a prolação de uma sentença de mérito. Nesse caso, o julgamento antecipado é autorizado pela disposição contida no artigo 355, inciso I, do CPC. Além disso, as partes, instadas a se manifestarem, afirmaram não necessitarem da produção de novos elementos probatórios, o que reforça o julgamento desta causa no estado em que atualmente se encontra.

Ademais, tendo em vista que a demandada se enquadra como plano de saúde de autogestão, nos termos da súmula 608, do STJ, não será possível a aplicação do CDC ao caso em testilha. Percebe-se, portanto, que a relação travada se trata de um contrato, regendo-se pelas disposições civilistas.

Sem mais delongas, afirma a ré que a análise da cobertura solicitada pela autora (fornecimento de medicamento) é prerrogativa exclusiva do TRT6 Saúde, conforme se depreende das cláusulas quinta, parágrafos quinto e oitavo, e sexta, do contrato administrativo nº 017/2019. Ou seja, a demandante deveria ter solicitado a medicação junto à União, e não ao plano de saúde.

Por outro lado, a demandante informa que o seu médico-assistente requereu a utilização do medicamento DENOSUMABE – PROLIA – 60 MG/SC – 6/6 meses, 11/12/2020, porquanto fora detectado aumento da OSTEOPOROSE em alguns segmentos ósseos (fêmur e antebraço) da autora. Tal medicação deve ser administrada por procedimento via parenteral, por profissional devidamente habilitado, sendo recomendada a administração em ambiente específico, clínico ou hospitalar (não internado), por tempo indeterminado.

O laudo médico produzido pela médica-assistente, a Dra. Julia Maria Lacet Silva, CRM-PE 7679, atestando as informações e requerimentos acima consignados, foram colacionados pela requerente sob o ID 107491473. Também foram juntados laudos de tomografia e densitometria óssea.

A demandante também juntou a negativa da Unimed Recife (ID 107494038) referente à medicação Prolia 60 mg (Denosumabe), na medida em que tal medicamento não se encontra inserido no rol da ANS, bem como não possui cobertura contratual.

Pois bem, *in casu*, à luz da Constituição Federal, o direito à saúde se sobrepõe a qualquer outro, ainda que amparado por lei ou contrato. Os Laudos Médicos comprovam o quadro clínico, diagnóstico, da parte autora, bem como sua necessidade de submissão ao tratamento médico, objeto da presente lide, conforme já se posicionou, com as devidas ponderações, este juízo, em sede de decisão liminar, que deferiu a Tutela de Urgência requerida, inclusive.

Dito isto, é certo que o caso *sub judice* envolve fundamento basilar da nossa Carta Magna, qual seja, o da dignidade da pessoa humana. Abrangendo, também, por decorrência lógica, os direitos fundamentais à vida e à saúde, estes entendidos em seu sentido lato.
Vale aqui a transcrição do trecho dos ilustres autores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, em sua obra de Direito Constitucional Descomplicado, no que diz respeito ao direito à vida e à saúde:

> Não se resume o direito à vida, entretanto, ao mero direito a sobrevivência física. Lembrando que o Brasil, tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, resulta claro que o direito fundamental em apreço abrange o direito a uma existência digna, tanto sob o aspecto espiritual quanto material (garantia do mínimo necessário a uma existência digna, corolário do Estado Social Democrático). Portanto, o direito individual fundamental à vida possui duplo aspecto: sob o prisma biológico traduz o direito à integridade física e psíquica (desdobrando-se no direito à saúde, na vedação à pena de morte, na proibição do aborto etc); em sentido mais amplo, significa o direito a condições materiais e espirituais mínimas necessárias a uma existência condigna à natureza humana.

É entendimento pacífico na jurisprudência, que inobstante o reconhecimento do direito dos planos de saúde de estabelecerem quais doenças estão excluídas da cobertura securitária, não lhes é dado a escolha do tratamento, cuja definição cabe, exclusivamente, ao médico que assiste ao paciente, sob pena de, agindo assim, o plano de saúde restringir os direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual.
Nesse sentido "**a operadora do plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente** (...)" (AgInt no AREsp 1.072.960/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 08/09/2017). (grifo nosso)
É o caso dos autos, pois incontroverso que a doença em questão tem cobertura contratual, o plano apenas se nega a fornecer o tratamento prescrito pelo médico-assistente. Ilegal a conduta descrita, portanto.
Aliás, em leitura detida da peça contestatória, verifico que a ré não nega a existência dos problemas de saúde que acomete a autora, nem a necessidade do tratamento indicado, e muito menos afirma que a indicação do médico não é devida ao caso concreto, mas apenas sustenta que não tem a obrigação de custeá-la, seja porque o pedido administrativo deveria ser junto à União (por intermédio do TRT6), seja porque não possui cobertura contratual, bem como o medicamento não está no rol da ANS.
Importante ressaltar que o medicamento receitado/prescrito, PROLIA (DENOSUMABE) 60mg, tem autorização/aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA/Ministério da Saúde, sendo seu uso regulamentado por este órgão - registro sob o nº 1024400130011.
Ademais, o medicamento deverá ser administrado por via parenteral, sendo recomendada a administração em ambiente específico, clínico ou hospitalar (não internado). Ou seja, não se trata de medicação domiciliar, muito menos em nada tem a ver com o requerimento de Home Care, conforme menciona a ré em sua peça de defesa. Ora, tais alegações descontextualizadas com os fatos só mostra o descaso do plano réu com sua cliente, ora, autora.

Por amor ao debate, destaco que a Lei nº 14.454/22 dispõe sobre a polêmica taxatividade ou exemplificatividade do Rol da ANS. Tal regramento jurídico estabelece critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos nele.

Conforme os termos da referida lei, o tratamento ou o procedimento que não estiver previsto no Rol da ANS deverá ser coberto pelos planos de saúde, desde que exista a comprovação científica de sua eficácia ou haja recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de pelo menos um órgão de avaliação de renome internacional.

Nesse sentido, verifico que a demandante juntou aos autos estudo contido no Manual Brasileiro de Osteoporose que indica a utilização do Prolia, concluindo que "*é uma das opções terapêuticas efetivas, evidenciando redução significativa de fraturas vertebrais, não vertebrais e de quadril, além de demonstrar segurança para pacientes com osteoporose e alto risco de fratura, com uma adequada taxa de aderência ao tratamento. A descontinuação do tratamento com Dmab (DENOSUMABE) pode levar à reversão dos benefícios obtidos na DMO e aumento do risco de fratura; nesse caso, deve-se considerar a troca para outro tratamento da osteoporose.*" - DOC de ID 107494039.

Ainda, o plano réu em nenhum momento refuta que o tratamento recomendado pela médica-assistente não encontra comprovação científica de sua eficácia e ampla aplicação pela medicina brasileira.

Ante o exposto, a confirmação dos efeitos da tutela de urgência (obrigação de fazer), anteriormente deferida, nos seus exatos termos, é a medida que se impõe.

Em relação aos **danos morais** requeridos, a aflição causada ilicitamente à segurada, em razão da necessidade de realização do tratamento medicamentoso indicado nos autos, nos moldes prescritos, e da negativa no atendimento de seu requerimento, não deve ser considerada como mero desconforto cotidiano, mas sim como autêntico dano moral, sobretudo em razão da gravidade de seu quadro clínico e diagnóstico, necessitando de um atendimento/tratamento célere e eficiente.

Assim, tenho por reconhecer a responsabilidade civil da demandada, pois o abalo moral demonstrado e sofrido pela parte autora, em virtude da injustificável recusa por parte da ré, constitui dano moral indenizável.

Neste sentido, é o disposto na Súmula 35, do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco:

> **<u>Súmula 035 - TJPE</u>. A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral.**

Nessa toada, levando-se em consideração os critérios e as considerações aqui apresentadas, em especial o caráter compensatório da indenização por dano moral, todos visualizados e recomendados pela doutrina, fixo o *quantum* indenizatório do dano moral na importância de **R$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, por vislumbrar que tal quantia se mostra suficiente para atender aos anseios reparatórios, punitivos, profiláticos e pedagógicos da reprimenda.

Um valor acima do fixado parece-me desproporcional, e se menor, não alcançaria o objetivo visado pelo instituto da responsabilidade civil.

DECISÃO:

Ante o exposto, julgo **PROCEDENTE** o pleito autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

A) Confirmar a Tutela Antecipatória deferida sob o ID 107703064, para que a ré tome todas as providências necessárias à cobertura das despesas relativas ao fornecimento do medicamento/tratamento especificado no Laudo Médico de ID 107491473;

B) CONDENO ainda a demandada a pagar à parte autora danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que fixo tendo por parâmetro a natureza e extensão do prejuízo, o grau de culpa do ofensor, as condições das partes e o caráter pedagógico da imposição, com aplicação dos juros de mora a partir da data da citação e correção monetária incidente a partir da data do arbitramento do valor da indenização, ou seja, da prolação definitiva desta sentença;

C) Condeno ainda a parte suplicada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (danos morais), devidamente atualizado pela tabela da ENCOGE, desde a publicação da presente decisão.

Pelo que **EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO**, com base no artigo 487, inciso I, do CPC.
Intimem-se as partes desta sentença.
Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as determinações desta sentença, e tomadas todas as medidas para salvaguardar o interesse público no recolhimento de eventuais custas finais, arquivem-se os autos.

RECIFE, 13 de junho de 2023.

Dr. Carlos Eugênio de Castro Montenegro

Juiz de Direito

gaal

Assinado eletronicamente por: CARLOS EUGENIO DE CASTRO MONTENEGRO
13/07/2023 13:35:27
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 132464396

23071313352702100000129405318

IMPRIMIR GERAR PDF